

受檢者基本資訊

姓名：●●●

年齡： 58

性別： 男

病歷號：●●●●

腹部CT檢查日期： 20241221

AI 分析日期： 20241223

綜合判斷/總結

Highly suspected pancreatic head cancer with abutment of the SMV and common hepatic artery, accompanied by regional lymphadenopathy. 高度懷疑胰臟頭部癌，與腸系膜上靜脈（SMV）及肝總動脈相貼近，並伴隨區域性淋巴結病變。

A tiny right lower lobe lung nodule. 右下肺葉可見一個小結節。

給您的提醒與建議：

本次檢查懷疑您的電腦斷層影像有胰腺癌，由於必須在顯微鏡下檢視胰臟組織發現有腺癌細胞才算確診為胰腺癌，因此目前還不能百分之百確定您有胰腺癌。胰腺癌的進展速度可能很快，請您務必盡速就醫，由醫師評估是否需安排組織切片化驗與其他進一步的檢查，以決定適當的治療策略。

胰腺癌的治療以手術切除與化學治療為主，部分病人可配合使用放射治療、免疫治療或標靶藥物。對於腫瘤可以切除的病患，應考慮外科手術切除腫瘤，術後追加輔助性化療可以進一步降低術後復發的機會。

若是經醫師評估認為手術可能難以完全切除腫瘤，或是手術切除後復發風險偏高，可以考慮先接受化學治療 (前導性化療)，若腫瘤在化療後縮小再進行手術切除腫瘤。

若是腫瘤侵犯附近重要的血管導致無法手術切除腫瘤，或是腫瘤已經擴散形成遠處轉移 (例如轉移到肝、肺)，則不適合接受手術，此時化學治療為主要的治療方式。由於近年化學治療的進步，部分一開始無法以手術切除腫瘤的患者在接受化學治療後腫瘤縮小，而有機會手術切除腫瘤。

診斷與治療胰腺癌需要專業與深入的醫療評估，請您盡速到醫療機構就診，尋求醫師的正式醫療評估與診治。

若您需要後續胰臟醫療的轉介協助，您可以掃描 QR Code 取得進一步的資訊。



您的 PANCREASaver 助胰見 分析結果

姓名: [REDACTED]

腹部電腦斷層檢查日期: 20241221

年齡: 58

助胰見分析日期: 20241223

性別: 男

病歷號: [REDACTED]

影像有 (無) 下列會影響判讀正確性之情形

- ☐ 無施打顯影劑之電腦斷層影像。
- ☐ 未滿 18 歲之兒童/未成年之電腦斷層影像。
- ☐ 胰管或膽管有置入支架者之電腦斷層影像。
- ☐ 胰腺接受過治療之電腦斷層影像，包含：手術、化學治療、放射治療、免疫治療等。
- ☐ 影像中之胰腺不完整者 (例如：曾接受胰臟切除手術者，攝影時未拍攝到完整胰臟等)。
- ☐ 急性胰臟炎或慢性胰臟炎急性發作導致部分組織壞死或積水，此時難以確認或排除潛藏胰臟癌的可能性；建議等待急性期緩解後，再檢查判斷。對於電腦斷層影像上顯現重度慢性胰臟炎變化 (如顯著的鈣化、胰管擴張/結石) 之病患，本產品判讀之正確性尚需進一步驗證。
- ☐ 肝門靜脈阻塞引發胰腺週邊形成側枝靜脈曲張之電腦斷層影像。
- ☒ 以上皆無，本影像適合分析。

助胰見 AI 分析結果

陽性 Positive

影像專科醫師的判讀
病灶大小：3.3 cm

醫師判讀結果

A 3.3 cm hypoenhanced mass lesion at pancreatic head with p-duct dilatation up to 5 mm; abutment of SMV and common hepatic artery is noted. Pancreatic cancer is considered. 胰臟頭部可見一個 3.3 公分的低增強（低顯影）腫塊，並伴隨胰管擴張至約 5 毫米。該腫塊與腸系膜上靜脈（SMV）及肝總動脈相貼近，考慮為胰臟癌。

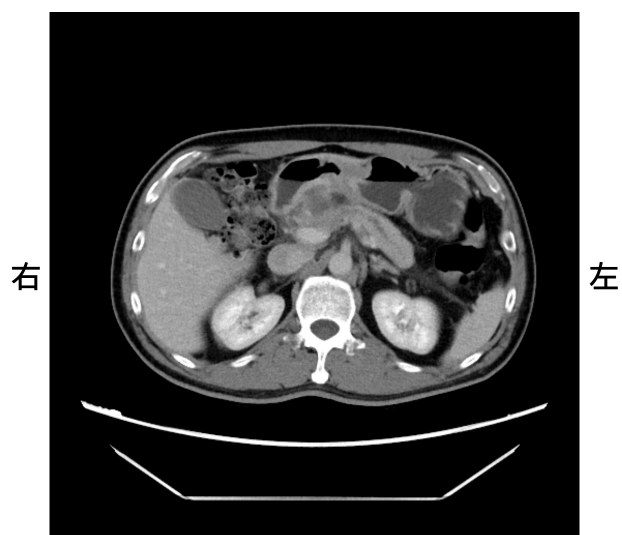
Multiple enlarged peripancreatic lymph nodes, suggestive of regional lymphadenopathy. 胰臟周圍淋巴結腫大，顯示可能有區域性淋巴結病變。

A 5 mm lung nodule in right lower lobe. 右下肺葉可見一個 5 毫米的肺結節。

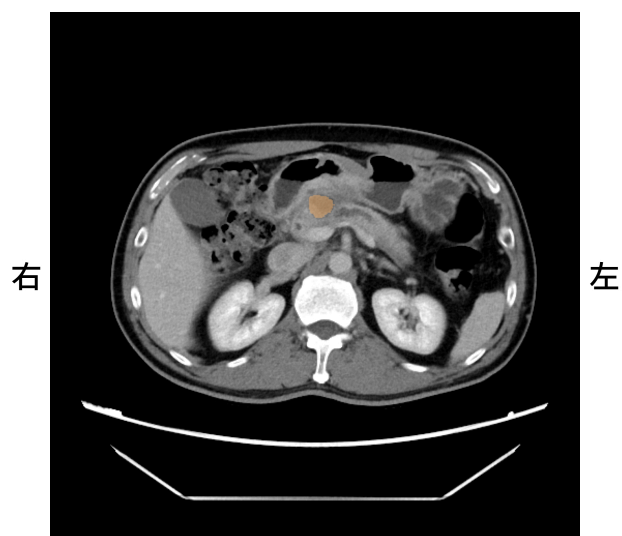
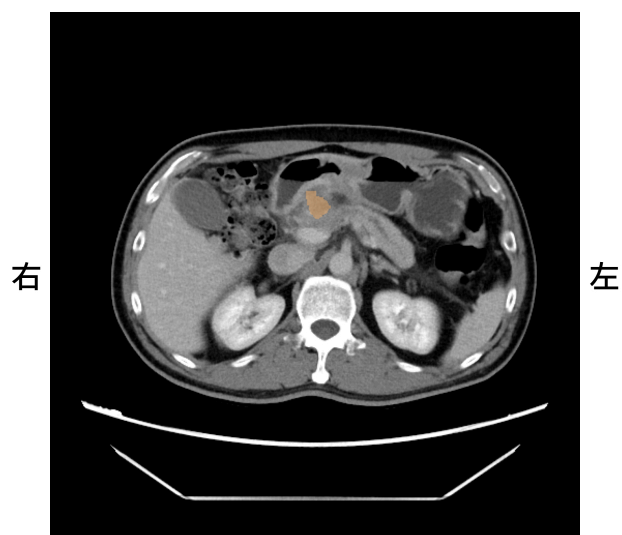
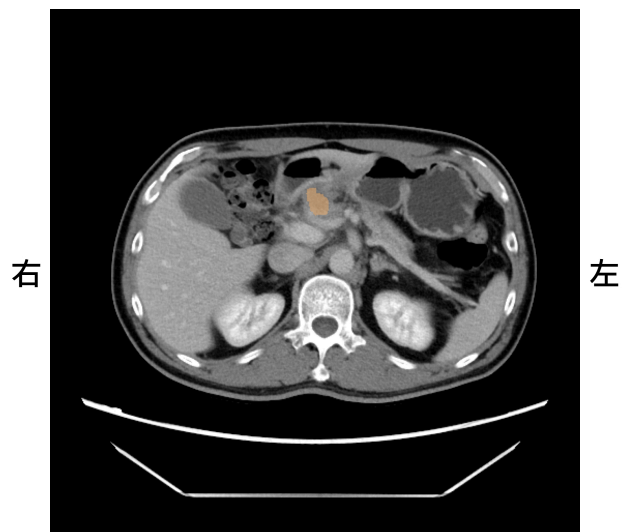
請注意

電腦斷層影像並非診斷胰臟疾病的唯一依據，尚需參考其他檢查及臨床資訊。助胰見的判讀結果不能取代專業醫師之診斷。本檢測僅針對胰臟進行進階影像分析，分析範圍不包含其他腹部器官。關於其他腹部器官之影像發現請參閱原本的電腦斷層檢查報告。

電腦斷層原圖



助胰見分析圖



著色區域為助胰見判讀疑似異常處

電腦斷層原圖

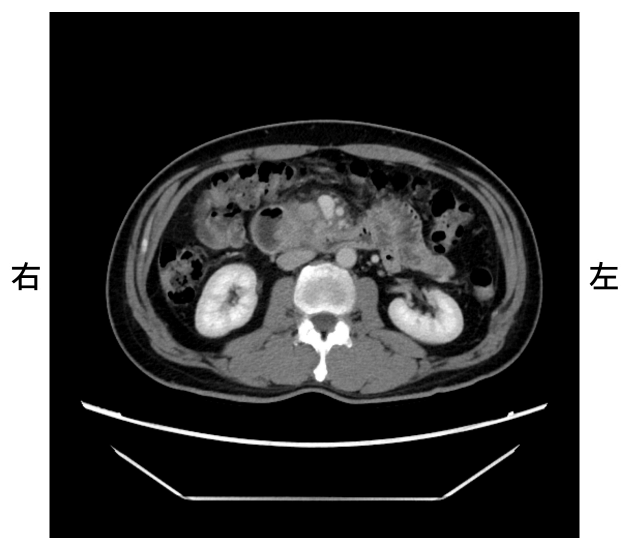
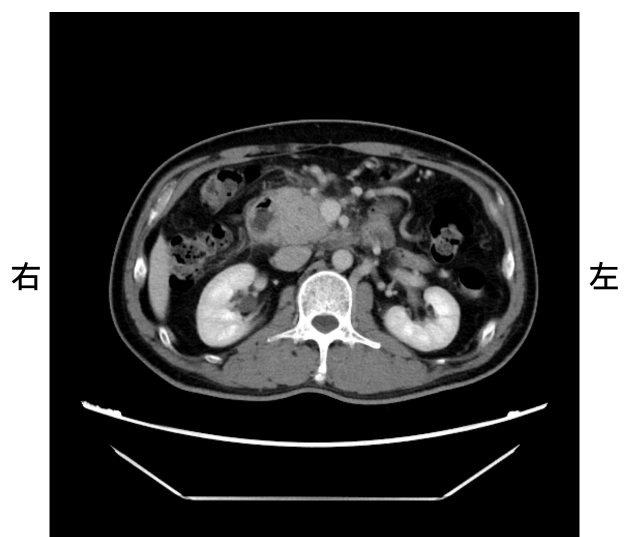
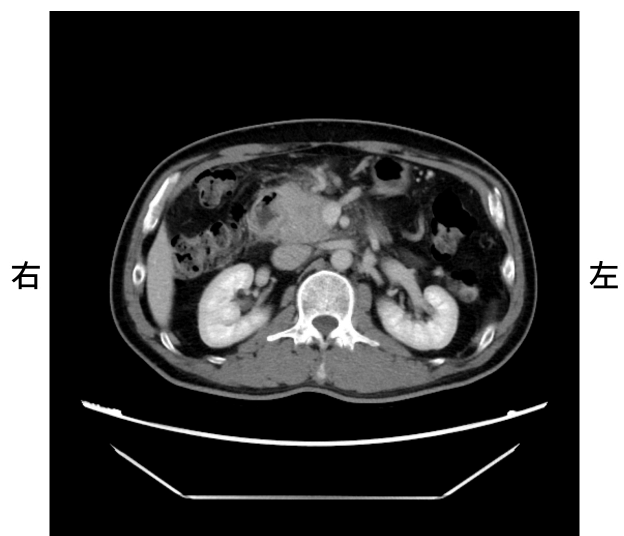


助胰見分析圖

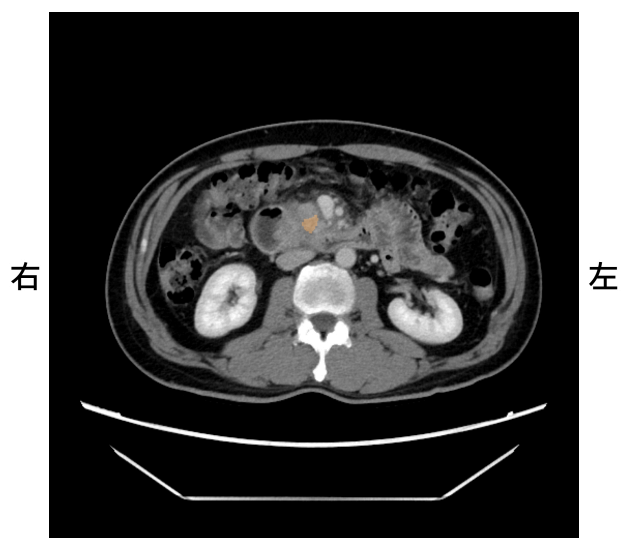
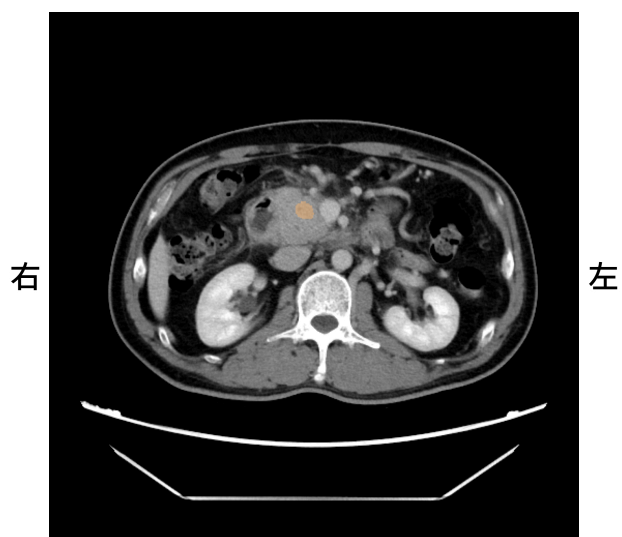
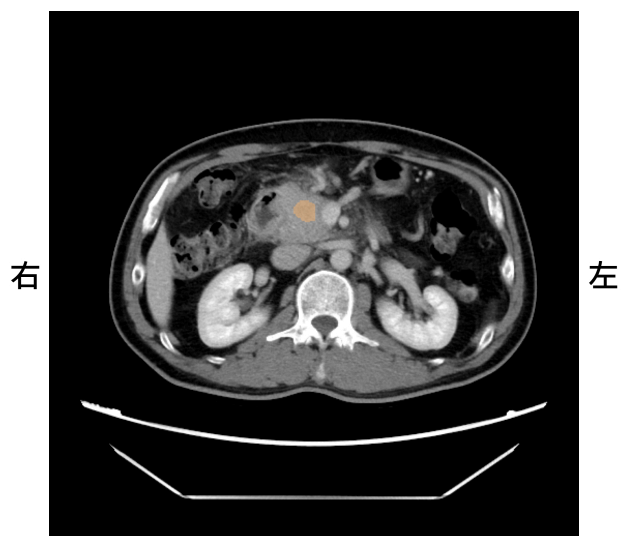


著色區域為助胰見判讀疑似異常處

電腦斷層原圖



助胰見分析圖



著色區域為助胰見判讀疑似異常處

電腦斷層原圖



助胰見分析圖

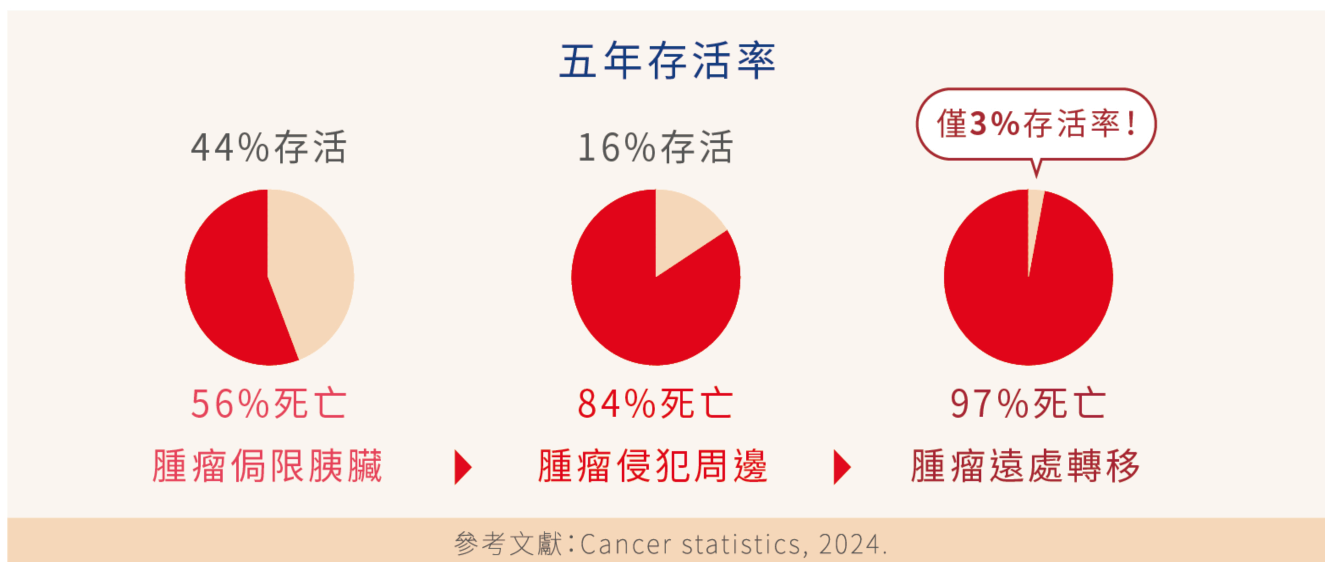


「胰腺癌」簡介

通稱胰臟癌 致死率最高癌症

胰腺癌 (胰臟癌) 約佔所有胰臟惡性腫瘤九成，是惡化速度最快、致死率最高的癌症。

早期胰腺癌在影像檢查上的變化常常不明顯，甚至是肉眼看不見，研究顯示高達近四成的小於兩公分的第一期胰腺癌未能在電腦斷層影像上被偵測。



另一方面，良性胰臟疾病在電腦斷層影像上的表現可能跟胰腺癌難以區分，有時良性胰臟疾病會掩蓋同時存在的早期胰腺癌，或是在長期追蹤後演變為胰腺癌。

因此僅依靠影像檢查來診斷胰臟疾病無法達到百分之百的正確性，還需考慮臨床癥狀與其他檢查的結果，複雜的病例甚至需要切片化驗與追蹤才能確定診斷。

基由胰臟疾病的複雜性以及影像檢查的侷限，請您務必跟專業的醫師討論本次檢測與其他相關檢查的結果，才能獲得最適當的醫療處置。

關於助胰見 (PANCREASaver)

助胰見是世界首創的人工智慧胰腺癌輔助偵測系統，經衛生福利部食品藥物管理署核准，用於輔助專業醫事人員分析18 歲以上成人之腹部電腦斷層 (CT) 影像，以辨識出疑似患有胰腺癌而需要更進一步檢查之病患，同時標示出疑似胰腺癌之位置，提供醫師參考。

助胰見的獨特優勢

近四成小於兩公分的早期胰腺癌難以靠肉眼偵測。憑藉多項獲得 **台灣與美國專利的創新技術**，助胰見 (PANCREASaver) 具有能偵測肉眼難以發現的**早期胰腺癌的獨特優勢**，在台大醫院與全國資料的測試中對於小於兩公分的胰腺癌之偵測率可達八成。由於具有創新科技與能提升早期胰腺癌偵測率的獨特優勢，助胰見 (PANCREASaver) 榮獲 **美國食品藥物管理署 (U.S. Food and Drug Administration) 認定為「突破性醫材 (Breakthrough Device)」**。

請注意

胰腺癌佔所有胰臟惡性腫瘤之九成，是最惡性的胰臟腫瘤。助胰見之功能為偵測胰腺癌，不包括偵測其他種類的胰臟腫瘤，如胰臟神經內分泌細胞瘤等。

僅依靠影像檢查來診斷胰臟疾病無法達到百分之百的正確性，即使是最有經驗的醫師或是任何影像分析工具，都仍然有其侷限，必須配合臨床表現與其他檢驗，綜合判斷。

© 版權所有。未經明確授權，嚴禁對本報告內容進行全部或部分的複製、抄襲、展示或任何形式使用。